

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA NACIONAL

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA) | 2026

Versión breve para el equipo de salud



Ministerio
de Salud
República Argentina

Autoridades

Presidente de la Nación

Dr. Javier Gerardo Milei

Ministro de Salud de la Nación

Dr. Mario Iván Lugones

Secretario de Gestión Sanitaria

Dr. Saúl Flores

Subsecretaria de Planificación y Programación Sanitaria

Dra. María de las Mercedes Ibero

Contenido

Autoridades	2
Contenido	3
Acerca de esta guía	4
Abreviaturas	4
Población beneficiaria	5
Fundamentación	5
Claves de esta guía	6
Vía Clínica HTA	7
1. Prevención	8
2. Diagnóstico y puntos de corte	8
3. Metas del tratamiento	12
4. Tratamiento no farmacológico	13
5. Tratamiento farmacológico	17
6. Evaluación del riesgo cardiovascular	19
7. Detección de daño de órgano blanco	20
8. Adherencia al tratamiento	23
9. Manejo de la urgencia hipertensiva	23
10. Anexos	26
Anexo 1. Tabla de fármacos y dosis por grupos farmacológicos	26
Anexo 2. Adherencia al tratamiento	27
Anexo 3. Pruebas para evaluar fragilidad	31
Anexo 4. Pronóstico de la enfermedad renal crónica según categorías de filtrado glomerular y albuminuria	34
Anexo 5. Herramientas para identificar factores psicosociales	35
Referencias	38

Acerca de esta Guía

El presente documento constituye la versión breve de la “**Guía de Práctica Clínica Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, actualizada 2024**” y forma parte del conjunto de acciones que el Ministerio de Salud de la Nación (MSN) lleva adelante para mejorar la calidad de atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)^[1].

Abreviaturas

AI: aurícula izquierda.

ACV: accidente cerebrovascular.

AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

CDF: combinación de dosis fijas de dos o más antihipertensivos en una píldora única.

DM2: diabetes mellitus 2.

EA: evento adverso de un fármaco.

ECG: electrocardiograma.

ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles.

ERC: enfermedad renal crónica.

FGe: índice de filtrado glomerular estimado. Se expresa en ml/min/1,73m².

GPC: guía de práctica clínica.

HTA: hipertensión arterial.

HVI: hipertrofia ventricular izquierda.

IMC: índice de masa corporal (peso en kg/talla en metros al cuadrado).

IC: insuficiencia cardíaca (IC).

MAPA: monitoreo ambulatorio de presión arterial.

MDPA: monitoreo domiciliario de presión arterial.

meq/l: miliequivalentes por litro.

mmHg: milímetros de mercurio.

MSN: Ministerio de Salud de la Nación.

PA: presión arterial.

PAD: presión arterial diastólica.

PAS: presión arterial sistólica.

RACo: relación albúmina/creatinina en muestra aislada de orina.

REx: recomendaciones extrapoladas de otras GPC o documentos del MSN.

Abreviaturas de fármacos:

- *AC-D: antagonistas cálcicos del grupo dihidropiridinas (ej. amlodipina).*
- *ARAI: antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ej. losartán).*
- *BB: betabloqueantes (ej. atenolol).*
- *IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ej. enalapril).*
- *TZ-STZ: diuréticos del grupo tiazida o símil tiazida (ej. hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida).*

Esta guía breve tiene como propósito:

Diseminar e implementar la GPC Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, actualizada 2024, incorporando herramientas prácticas que faciliten la aplicación de las recomendaciones.

Para ello integra:

- Las 43 recomendaciones sobre hipertensión arterial:

1. Prevención
2. Diagnóstico y puntos de corte
3. Metas de tratamiento
4. Tratamiento no farmacológico
5. Tratamiento farmacológico
6. Adherencia al tratamiento
7. Detección de daño de órgano blanco
8. Manejo de la urgencia hipertensiva

- Recomendaciones aportadas por otras guías del MSN sobre factores de riesgo y enfermedades crónicas no transmisibles.
- Textos explicativos, cuadros, algoritmos y otras herramientas prácticas.

EL DOCUMENTO COMPLETO DE LA GUÍA QUE INCLUYE LA METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN Y LA EVIDENCIA QUE SUSTENTA LAS RECOMENDACIONES (VERSIÓN EXTENSA)
PUEDE CONSULTARSE EN: <https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo>

Población beneficiaria

La guía se dirige a personas de 18 o más años de edad, con o sin diagnóstico de hipertensión arterial (HTA), en el marco de la atención ambulatoria asistida principalmente en el primer nivel de atención.

Fundamentación

La HTA constituye el principal factor de riesgo cardiovascular, asociándose al desarrollo de enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca (ICC), fibrilación auricular (FA), aneurisma de aorta, disección de aorta, enfermedad vascular periférica, demencia y enfermedad renal crónica (ERC), impactando negativamente en la mortalidad total, la discapacidad y los costos sociosanitarios ^[2].

La 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR, 2018) que incluyó mediciones de presión arterial (PA), muestra ^[3]:

- **Prevalencia de HTA por autorreporte** en torno al 35%, similar a ediciones previas.
- **Prevalencia de HTA combinada** del 46,6% (incluye a quienes se reconocen hipertensos y toman antihipertensivos o presentaron valores elevados de presión arterial al momento de la encuesta).
- **Subdiagnóstico:** entre quienes respondieron no tener HTA, 3 de cada 10 presentaron presión arterial elevada.
- **Mal control:** 6 de cada 10 personas que respondieron tener HTA, tuvieron la presión arterial elevada al momento de la encuesta.

Claves de esta guía

- La importancia del estilo de vida saludable para la prevención y control de la HTA.
- El rastreo de HTA a partir de los 18 años manteniendo el punto de corte de diagnóstico en 140/90 mmHg.
- La toma de presión arterial en consultorio como método diagnóstico.
- Meta general menor a 140/90 mmHg. En personas con alto riesgo y buena tolerancia, 130/80 mmHg. En mayores de 80 años recién diagnosticados, se flexibiliza hasta 150/90 mmHg.
- Iniciar el tratamiento farmacológico con dos antihipertensivos a dosis bajas.
- No retrasar el inicio del tratamiento farmacológico por estudiar daño de órgano blanco.
- Detección de daño de órgano blanco dentro del año del diagnóstico: ECG, relación albúmina/creatinina en muestra aislada de orina (RACo) y estimación del filtrado glomerular (FGe).
- La adherencia al tratamiento como aspecto central para el control de la presión arterial.
- Manejo ambulatorio de la urgencia hipertensiva con descenso gradual de las cifras de presión arterial.

Vía Clínica HTA

> Hipertensión Arterial

A LECTURA PRECISA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

*Si disponibles, utilizar dispositivos automáticos validados para el brazo.

B RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV)

Estimar a partir de los 40 años

Con Enfermedad CV establecida: Aspirina + Rosuvastatina 20 mg por día.

Sin Enfermedad CV establecida: Rosuvastatina 10 mg por día (independiente del valor de colesterol).

ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR (Diabetes, ERC, Riesgo > 10%)

Calculadora de riesgo cardiovascular

Diagnóstico de HTA:
 Mayor o igual a 140/90 mmHg confirmada en 2 visitas.

METAS Presión arterial < 140/90. En pacientes de Alto Riesgo CV Presión arterial Sistólica ≤ 130

C PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Iniciar tratamiento farmacológico inmediatamente al momento de confirmación de diagnóstico.
Si el paciente sigue fuera de meta luego de 4 semanas, proceder al paso siguiente.

- 1 Losartán 25 mg + Amlodipina 2.5 mg en una toma diaria
- 2 Losartán 50 mg + Amlodipina 5 mg en una toma diaria
- 3 Losartán 100 mg + Amlodipina 10 mg en una toma diaria
- 4 Losartán 100 mg + Amlodipina 10 mg + Hidroclorotiazida 25 mg en una toma diaria

Información Adicional

- Valorar adherencia previo a intensificar el tratamiento.
- Evaluar indicación de beta-bloqueantes en personas con enfermedad coronaria establecida.
- No combinar IECA y ARA II.
- Determinar anualmente daño órgano blanco: ECG, Filtrado glomerular, índice alb/Creat en muestra de orina matinal.
- No aplicar este algoritmo en embarazadas ni mujeres en edad fértil.

Realizar 30 minutos de actividad física diariamente

Mantener un peso adecuado

Alimentación saludable (con bajo contenido de sodio)

No fumar

Evitar el consumo de alcohol

D DERIVACIÓN OPORTUNA

- HTA refractaria: Refractoriedad al tratamiento con 3 o más drogas.
- Desarrollo enfermedad vascular (coronaria, cerebral o periférica).
- Sospecha de HTA secundaria.

E	SEGUIMIENTO					
	Cada 6 meses	Cada 3 meses	Suministro de medicación para 3 meses	Vacunación		
				Influenza	Neumococo	COVID-19
Todos los hipertensos	✓		✓			✓
Solo ALTO RIESGO		✓	✓	✓	✓	✓



La vía clínica de HTA es un resumen gráfico que contiene el conjunto de las principales recomendaciones de la GPC. Incluye el diagnóstico, la estratificación del riesgo cardiovascular, un protocolo estandarizado de tratamiento y las pautas para el seguimiento y derivación oportuna. Estandarizar procesos disminuye errores por acción u omisión, favorece el acceso equitativo a una atención de calidad y reduce la inercia terapéutica.

La vía clínica consolida en una única página 22 recomendaciones de las GPC de HTA y recomendaciones de otras GPC nacionales.

Puede descargarse de:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo>

1. Prevención

El desarrollo de Hipertensión Arterial (HTA) está estrechamente ligado a los estilos de vida actuales. La alimentación inadecuada con alto contenido de sodio, grasa y calorías, la inactividad física y el consumo de alcohol aumentan el riesgo de desarrollar HTA y otros factores de riesgo cardiovasculares (FRCV). Por su parte, el aumento sostenido de la obesidad ha contribuido a la aparición de HTA en edades más tempranas. El aislamiento social, estrés laboral, crisis vitales, ansiedad y/o depresión, también podrían contribuir al desarrollo de HTA.

Para reducir el riesgo de desarrollar HTA en adultos se recomienda:

- Realizar al menos **150 minutos semanales de actividad física** de intensidad moderada, en sesiones de al menos 30 minutos.
- Adherir a un plan de **alimentación adecuado reducido en sodio**: 5 gramos de sal, que equivalen a 2000 mg de sodio por día.
- **Limitar al menor consumo la ingesta de alcohol** y en personas que no consumen alcohol, **no alentar su inicio**.
- Considerar dentro de la valoración del riesgo cardiovascular individual, a los factores psicosociales como el **estrés, ansiedad y depresión**.

2. Diagnóstico y puntos de corte

Se recomienda el rastreo de HTA a todas las personas de 18 o más años mediante la toma de presión arterial en consultorio.

¿Cuál es la frecuencia de rastreo?

- En personas de entre 18 y 40 años sin factores de riesgo y PA igual o menor a 130/80 mmHg: al menos 1 vez cada 3 a 5 años.
- En personas mayores de 40 años o en presencia de factores de riesgo o valores de presión arterial sistólica (PAS) 130 a 139 y/o presión arterial diastólica (PAD) 80 a 89 mmHg: al menos 1 vez al año.

A LOS FINES PRÁCTICOS, PUEDE SER CONVENIENTE TOMAR LA **PA** EN CADA CONTACTO CON EL SISTEMA DE SALUD.

¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar HTA?

- Edad
- Sobrepeso/obesidad
- Sedentarismo o actividad física insuficiente
- Elevado consumo de sodio
- Uso crónico de corticoides o antiinflamatorios no esteroides (AINE)
- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Diabetes mellitus
- Historia de HTA en familiares de 1º grado, entre otros.

Siempre que esté disponible se sugiere emplear **tensiómetros automáticos** validados de brazo, para obtener **valores más precisos y reproducibles de la PA**, ya que evitan la subestimación por el vacío auscultatorio (*gap sistólico*), el redondeo de las cifras obtenidas y poseen menos variabilidad interobservador.

Técnica de toma de presión arterial

Respetar la técnica de toma de presión arterial es un aspecto clave para garantizar la validez de los valores hallados.

a) Condiciones de la toma:

- Evitar el consumo de cafeína, mate, tabaco y la práctica de ejercicio 30 minutos antes de la medición.
- Permanecer al menos 5 minutos en reposo, sentado tranquilo y en silencio, antes de realizar las mediciones.

b) Posición:

Sentada, ambos pies apoyados en el piso y sin cruzar las piernas; la espalda sobre el respaldo de la silla; el brazo desnudo, evitando arremangar la ropa, para que ésta no lo comprima; apoyado cómodamente con la palma hacia abajo para evitar contraer los músculos, de modo que, el punto medio del húmero se encuentre a la altura del corazón.

EN LA PRIMERA CONSULTA, TOMAR LA PA EN AMBOS BRAZOS Y HACER EL SEGUIMIENTO ULTERIOR EN EL BRAZO QUE PRESENTE LOS VALORES MÁS ELEVADOS.

c) Elección y colocación del manguito:

El manguito tiene que cubrir el 80% a 100% de la circunferencia del brazo en adultos. Colocar el borde inferior del manguito 2 cm por encima del pliegue del codo.

d) Medición:

■ **Tensiómetro automático validado (método oscilométrico):**

Presionar el botón, aguardar a que el aparato devuelva la cifra de presión arterial y anotarla, tal cual se muestra, **sin redondeos**. Esperar 30 segundos y repetir la operación, en caso de que el proceso no se repita automáticamente. **Promediar** ambas mediciones y registrar el valor final, **evitando el redondeo de cifras**.

■ **Tensiómetro aneroide:**

Colocar la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral, sin que quede cubierta por el manguito. Insuflar el manguito 20 a 30 mmHg por encima del punto en que desaparece el pulso radial y desinsuflar a una velocidad de 2 mmHg/segundo, para detectar el momento preciso en que aparecen los ruidos de Korotkoff. Realizar al menos 2 mediciones, promediando las mismas. Si la diferencia de las tomas es mayor a 10 mmHg en la PAS y/o 5 mmHg de la PAD, realizar al menos una medición adicional.

e) Registro:

Consignar en la historia clínica tanto el brazo como los valores (promedio sin redondear).

Sospecha de errores diagnósticos

Si se sospecha “HTA de guardapolvo blanco” o “HTA oculta” se recomienda realizar un monitoreo domiciliario de presión arterial (MDPA) o bien, un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 hs (MAPA).

“HTA de guardapolvo blanco”: valores persistentemente elevados de presión arterial en consultorio con normotensión ambulatoria y sin presencia de daño de órgano blanco.

“HTA oculta”: valores normales de presión arterial en el consultorio, pero con cifras elevadas de presión arterial fuera del mismo. Se sospecha en aquellas personas con presión arterial normal en consultorio que presenten daño de órgano blanco (por ejemplo, el hallazgo de hipertrofia ventricular izquierda).

Monitoreo domiciliario de la presión arterial (MDPA)

- Respetar las condiciones de la toma.
- Realizar las mediciones preferentemente antes del desayuno y la cena.
- Realizar dos mediciones antes del desayuno y dos antes de la cena, al menos por cuatro días (idealmente).
- Promediar los valores, excluyendo los registrados el primer día.

Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)

- Se considera el método de referencia para el diagnóstico de HTA.
- Se utilizan equipos automáticos que se colocan y mantienen generalmente durante 24 hs.
- Permite evaluar la PA nocturna y la variabilidad relacionada con las actividades cotidianas.
- Sus principales desventajas incluyen el mayor costo, la menor disponibilidad y que puede ocasionar incomodidad, especialmente durante las horas de sueño.^[4]

Criterios diagnósticos de HTA según el método utilizado

Método de medición de presión arterial	PAS (mmHg) igual o mayor a		PAD (mmHg) igual o mayor a
En consultorio	140	y/o	90
MAPA			
Promedio diurno	135	y/o	85
Promedio nocturno	120	y/o	70
Promedio de 24 horas	130	y/o	80
MDPA	135	y/o	85

En qué casos sospechar HTA secundaria^[5]

- HTA resistente a fármacos o inducida por fármacos (descongestivos, AINE, medicamentos herbales).
- Inicio abrupto de la HTA.
- Inicio de HTA antes de los 30 años.
- Empeoramiento de una HTA previamente controlada.
- Daño a órgano diana desproporcionado para el grado de HTA.
- HTA acelerada o maligna.
- Inicio de HTA diastólica en adultos mayores (≥ 65 años).
- Hipopotasemia no provocada o excesiva.
- Insomnio o somnolencia diurna.
- Nódulo suprarrenal concomitante.
- Antecedente de ictus de inicio temprano.

Causas más frecuentes de HTA secundaria

- Enfermedad renovascular y enfermedades del parénquima renal.
- Apnea obstructiva del sueño.
- Hiperaldosteronismo primario.

Su abordaje excede los alcances de la presente GPC. Ante su sospecha se requiere el manejo conjunto con el área correspondiente.

3. Metas del tratamiento

Las metas varían según la edad y la presencia o no de factores de riesgo cardiovascular asociados.

- **Se recomienda meta general:** valores de presión arterial menores a 140/90 mmHg.
- **Considerar valores cercanos a 130/80 mmHg en personas con alto riesgo cardiovascular** (ej.: daño de órgano blanco, múltiples factores de riesgo y/o comorbilidades, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o eventos cardiovasculares previos), **y bajo riesgo de efectos adversos** (ej. jóvenes, sin historia de efectos adversos por fármacos, sin signos de fragilidad).
- **En personas con HTA de 80 años y más que inician tratamiento antihipertensivo considerar valores de presión arterial en consultorio menores a 150/90 mmHg.**
- **En quienes se encuentren bajo tratamiento desde edades más temprana, presenten valores menores a 140/90 mmHg y no presenten efectos adversos, no es aconsejable disminuir la medicación solo por alcanzar los 80 años.**
- **En personas de 80 o más años o con signos de fragilidad que deambulan por sus medios, se sugiere tener en cuenta las cifras de presión arterial sistólica tomadas en posición de pie** (luego de al menos un minuto en esa posición), para guiar el tratamiento y evitar los riesgos asociados a la hipotensión ortostática*.

**Se considera hipotensión ortostática a un descenso sostenido mayor a 20 mmHg en la presión arterial sistólica y/o 10 mmHg en la presión arterial diastólica dentro de los 3 primeros minutos de la bipedestación.*

A medida que aumenta la edad, el desarrollo de “rigidez arterial” conlleva un aumento marcado de la presión arterial sistólica, con valores estables o incluso menores de presión arterial diastólica. Debe sospecharse cuando una persona presenta valores muy elevados de presión arterial sistólica y síntomas de hipotensión asociados al empleo de fármacos antihipertensivos.

¿Cómo detectar la rigidez arterial?

Insuflar el manguito del esfigmomanómetro por encima de la presión arterial sistólica mientras se palpa la arteria radial. Si una vez ocluido el flujo humeral, la arteria radial continúa siendo palpable como “un tubo”, se dice que la maniobra es positiva y ello hace sospechar que los valores elevados sean falsos (maniobra de Osler. En estos pacientes se requiere considerar su evaluación por un experto en HTA.

En el anexo 3 encontrará herramientas para valorar la fragilidad.

4. Tratamiento no farmacológico

Mantener un estilo de vida y peso saludables favorecen el control de la HTA.

En adultos con HTA se recomienda:

1. Actividad física:

- Sumar al menos 150 minutos semanales de actividad física (AF) de intensidad moderada, preferentemente en sesiones no menores a 30 minutos o
 - ▶ 75 minutos de actividad física vigorosa o
 - ▶ una combinación equivalente de ambas.
- Disminuir el comportamiento sedentario.

En personas con HTA mal controlada, con valores que no superen los 160 mmHg de PAS o 100 mmHg de PAD, la realización de actividad física leve a moderada no se asociaría a incremento de complicaciones. En cambio, en quienes presenten valores mayores, resulta razonable posponer su inicio.

Para determinar la intensidad del ejercicio la persona puede usar el [Test del habla o Talk Test](#):

- **Intensidad leve:** se puede mantener una conversación de manera continuada durante un largo período de tiempo. Se puede hablar y cantar.
- **Intensidad moderada:** no se puede mantener una conversación continua. Se puede hablar, pero no cantar.
- **Intensidad vigorosa:** no se puede hablar ni cantar, sólo emitir monosílabos.

Para aumentar la actividad física en la vida cotidiana se aconseja:

- usar escaleras en lugar de ascensores,
- elegir transporte activo (andar a pie o en bicicleta, patines, patineta) en vez de transporte motorizado,
- realizar actividades de mantenimiento de la casa, limpieza, jardinería, entre otras.

Para disminuir el comportamiento sedentario se aconseja:

- pararse y moverse durante 3 minutos cada media hora cuando se realizan actividades sedentarias prolongadas; ej. subir y bajar un piso por escalera,
- limitar el tiempo frente a las pantallas.

Cuidados generales para la realización de actividad física

- Hidratación adecuada antes, durante y después de la actividad física.
- Entrada en calor al comienzo del ejercicio y elongación al finalizar.
- Mantener un horario de práctica regular, creando un hábito.
- Evitar las horas de máxima temperatura.

2. Alimentación adecuada reducida en sodio^[6]

Una alimentación adecuada, reducida en sodio (5 g de sal por día, que equivale a 2000 mg de sodio), que aporte la energía adecuada según la edad y condición, permite lograr y conservar un peso adecuado, y contribuye a evitar y controlar la diabetes mellitus 2 (DM2), HTA y a prevenir los eventos cardiovasculares.

Incluye:

1. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos.
2. Tomar a diario 8 vasos de agua segura.
3. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores.
4. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio.
5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal.
6. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados.
7. Al consumir carnes quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo.
8. Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca.
9. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas.

Reducción de sodio

Reducir la ingesta diaria de sodio reporta beneficios para toda la población (no solo para las personas con hipertensión) incluidos niños y adolescentes.

Se estima que el consumo diario de sal en nuestro país supera los 10 g (alrededor de 4000 mg de sodio), duplicando la recomendación actual.

El 70% del consumo diario de sodio corresponde a **la sal oculta**, que es aportada por los alimentos industrializados en forma de conservantes y aditivos. Por eso se sugiere promover la elección de alimentos frescos o mínimamente procesados, observar la cantidad de sodio que aportan los alimentos envasados y preferir los que no estén rotulados como **“exceso en sodio”**.

Para reducir el consumo de sal se aconseja:

1. Preferir alimentos naturales frescos o mínimamente procesados.
2. Cocinar sin sal. Si fuera necesario agregarle un poco al finalizar la preparación.
3. Evitar el salero en la mesa. En su reemplazo se puede utilizar pimentero para dar sabor y aroma a los platos. Luego de algunas semanas sin consumir sal, la preferencia por el sabor salado se reduce y se comienza a disfrutar el sabor natural de los alimentos.
4. Utilizar en su reemplazo: jugo de limón, vinagre, cebolla, ajo, hierbas aromáticas y especias: Orégano, Perejil (fresco o seco), Laurel, Pimentón (dulce o ahumado), Ají molido, Pimienta (negra o blanca), Ajo (fresco o deshidratado), Cebolla deshidratada, Comino, Romero, Tomillo, Nuez moscada, Albahaca, Coriandro (semilla molida), Hinojo, Cúrcuma, Jengibre (fresco o seco), Curry, Salvia, Estragón, entre otros.
5. No usar saborizantes en polvo o caldos deshidratados como condimentos.
6. Deshabituarse al paladar al sabor salado.
7. Retrasar y/o evitar la incorporación de sal en las comidas de los niños y adolescentes limitándola en el ámbito familiar.

3. Evitar el consumo de alcohol[7]

Se recomienda **limitar al menor consumo posible la ingesta de alcohol** (NUNCA más de una medida estándar por día en mujeres y dos medidas estándar por día en hombres). En personas que no consumen, **no alentar su inicio**.

Evitar completamente el consumo en niños, adolescentes y en embarazadas o en período de lactancia.

Para identificar la ingesta de alcohol, se recomienda preguntar a todas las personas que consulten al sistema de salud sobre el consumo de bebidas con alcohol (ej.: vino, cerveza, aperitivos, tragos, fernet, bebidas blancas, licor, entre otras). Para ello se sugiere utilizar como prueba inicial el cuestionario AUDIT-C (versión corta), mostrando al entrevistado lo que se considera una unidad de bebida estándar (UBE) para cada tipo de bebida.



Una UBE contiene 12 a 14 g de alcohol y equivale a:

- 330 ml (1 lata) de cerveza al 5%,
- 140 ml (media copa) de vino al 12%,
- 90 ml de vinos fortificados (ej.: jerez) al 18%,
- 70 ml de licor o aperitivo al 25%,
- 40 ml de bebidas espirituosas al 40% (ej.: vodka o fernet).

Cuestionario AUDIT-C

Preguntas	Puntaje				
	1	2	3	4	5
¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	Nunca	1 o menos veces al mes	de 2 a 4 veces al mes	de 2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana
¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal?	1 o 2	3 o 4	5 o 6	7 o 9	10 o más
¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario

Los puntos de corte sugeridos para la detección de consumo de riesgo o perjudicial de alcohol son de 4 o más para mujeres adultas y de 5 o más para hombres adultos.

El abordaje de las personas en las que se detecte un rastreo positivo puede consultarse en la [Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Intervención Breve para Reducir el Consumo de Alcohol](#)

4. Factores psicosociales concomitantes

Si la persona presenta estrés, ansiedad y/o depresión se sugiere, siempre que esté disponible, la práctica de 30 a 90 minutos semanales de alguna técnica con fines de relajación (por ejemplo: técnicas de respiración, meditación, musicoterapia, entrenamiento en asertividad, entre otras), para contribuir a mejorar el control de la presión arterial. Así también considerar el tratamiento de la depresión con el fin de reducir la mortalidad cardiovascular.

Ver anexo 5: herramientas para la detección de ansiedad y depresión.

5. Tratamiento del tabaquismo

El tabaco es factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular mayor. Se recomienda para incrementar la tasa de cesación: ^[8]

- **interrogar** a toda persona que consulta al sistema de salud sobre su consumo de productos de tabaco en todas sus formas, ya sea diario u ocasional (cigarrillo tradicional, para armar, dispositivos electrónicos - cigarrillo electrónico -, nuevos productos de tabaco calentado, bolsitas de nicotina, etc.) y la exposición al humo ambiental de tabaco o aerosol de los dispositivos electrónicos.
- **brindar un consejo** de varios minutos para dejar de fumar a toda persona que fuma, incluso

a quien fuma un cigarrillo al día u ocasionalmente y aconsejar que los hogares y vehículos sean siempre libres de humo (fumar siempre afuera).

- **ofrecer ayuda a quienes están listos para dejar** a través de intervenciones breves integradas a todo motivo de consulta o bien intensivas por personal entrenado con un estilo de atención motivacional, conteniendo consejería para la modificación del comportamiento y fármacos efectivos para la cesación (reemplazos nicotínicos y/o bupropion).

Para más información consultar la [Guía de Práctica Clínica Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco](#).

6. Prevención y tratamiento de la obesidad

La obesidad es factor de riesgo para desarrollar HTA y empeora su control.

La GPC de abordaje integral de la obesidad en adultos recomienda^[9]:

- Medir el **Índice de Masa Corporal** ($IMC = \text{peso} / \text{talla}^2$) y la **circunferencia de cintura** en personas con sospecha de obesidad, con previo consentimiento.

El descenso de peso reduce la presión arterial, la glucemia, el LDL colesterol, los triglicéridos (TG) y aumenta el HDL colesterol; probablemente mejore la calidad de vida, el síndrome apnea/hipopnea del sueño, las funciones cognitivas y reduzca la mortalidad cardiovascular y total. Reducciones del peso modestas, incluso menores al 5%, aportan beneficios para la salud.

Su abordaje puede consultarse en la [Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Abordaje Integral de la Obesidad en Adultos](#).

5. Tratamiento Farmacológico

Abreviaturas de fármacos:

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ej. enalapril),
 ARAII: antagonistas de receptores de angiotensina (ej. losartán),
 AC-D: antagonistas cálcicos del grupo dihidropiridinas (ej. amlodipina),
 TZ-STZ: diuréticos del grupo tiazida o simil tiazida (ej. hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida),
 BB: betabloqueantes (ej. atenolol)

En adultos de 18 años o más con HTA se sugiere como esquema de inicio dos antihipertensivos a dosis baja en lugar de un antihipertensivo a dosis media

Ante el diagnóstico de HTA, **NO demorar el inicio del tratamiento farmacológico**. Preferir fármacos combinados de una sola toma al día. Las combinaciones más estudiadas y disponibles en el mercado son las que asocian IECA o ARAII con AC-D o TZ/STZ.

Ver anexo 1 : tablas de dosis de fármacos.

Opciones recomendadas de combinación de 2 fármacos:

Tabla de combinación de 2 fármacos

Opciones preferenciales	IECA + AC-D ARAI + AC-D IECA + diurético (TZ-STZ) ARAI + diurético (TZ-STZ)
Opciones con BB	BB + AC-D BB + IECA BB + ARAI
Opciones menos utilizadas	BB + diurético (TZ-STZ), debido a sus efectos metabólicos AC-D + diurético (TZ-STZ), debido a que es una combinación menos estudiada

En mujeres en edad fértil NO usar IECA ni ARAI y, en quienes los reciben, suspender su uso si se constata embarazo para evitar efectos adversos graves en el feto.

Como regla general NO asociar IECA con ARAI por presentar elevado riesgo de efectos adversos (ej.: falla renal e hiperkalemia).

En los casos excepcionales en que resultara imprescindible (por ejemplo: en ciertos pacientes con nefropatía y proteinuria persistente a pesar del tratamiento adecuado con uno de los fármacos), esta asociación de fármacos podría considerarse siempre y cuando el paciente cuente con un seguimiento por nefrología, con estrecha monitorización de la función renal, del balance hidroelectrolítico y el control de PA.

Realizar visitas de **seguimiento en forma MENSUAL** hasta alcanzar metas.

Intensificar progresivamente el tratamiento **duplicando la dosis** de la combinación sin superar la dosis máxima **y/o adicionar un tercer fármaco**, hasta lograr metas o hasta alcanzar el uso de los 3 fármacos a dosis altas.

Referenciar a expertos en HTA si no se alcanzan metas de control de PA con tres fármacos a dosis altas o máxima dosis tolerada.

SIEMPRE evaluar adherencia y monitorear tolerancia y efectos adversos antes de intensificar.

En cada visita **reforzar recomendación de estilo de vida saludable** con alimentación baja en sodio, actividad física regular y limitar/evitar el consumo de alcohol y no fumar.

Ver vía clínica de HTA disponible en

<https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo>

Las combinaciones más utilizadas son:

- ARAI + AC-D + diurético (TZ-STZ)
- IECA + AC-D + diurético (TZ-STZ)

En quienes se encuentren **recibiendo 3 fármacos a dosis altas** (especialmente si el esquema incluye TZ-STZ), **monitorear la tolerancia y EA**, en particular las alteraciones hidroelectrolíticas. Los AC-D y los diuréticos son los fármacos antihipertensivos que presentan mayor tasa de eventos adversos (EA) cuando son llevados a dosis máximas.

En el anexo 1: encontrará tablas con las dosis de fármacos de los cinco grupos de antihipertensivos.

En personas con diabetes mellitus y/o con enfermedad renal crónica: incluir en el esquema de inicio un IECA o ARAII y mantenerlos en la intensificación.

Las personas con filtrado glomerular estimado (FGe) menor a 30 ml/min/1,73 m² requieren la evaluación conjunta con nefrología.

En adultos con HTA y enfermedad coronaria sin deterioro de función ventricular (con fracción de eyección mayor o igual al 50%), se recomienda: iniciar tratamiento con BB, IECA o ARAII. Si al mes del tratamiento y buena adherencia al mismo no se alcanza meta, asociar un segundo fármaco a dosis baja o media.

En personas que presentan **angina de pecho o síndrome coronario agudo reciente (menos de 1 año)**, se prioriza el uso de BB debido a sus propiedades anti-isquémicas.

6. Evaluación del riesgo cardiovascular

La GPC nacional de prevención cardiovascular recomienda estimar el riesgo cardiovascular global a todas las personas mayores de 40 años ^[10].

En personas SIN enfermedad cardiovascular (ECV) establecida recomienda:

1. estatinas de moderada intensidad si presentan:

- diabetes mellitus,
- enfermedad renal crónica en estadios G3a a G5, o
- riesgo cardiovascular mayor al 10% a 10 años.

2. estatinas de moderada a alta intensidad si presentan:

- LDL colesterol igual o mayor a 190 mg/dl o
- Colesterol total igual o mayor a 300 mg/dl,

independiente de la edad y de la presencia o no de otros factores de riesgo. Ante estos valores, interconsultar con profesional con experiencia para descartar hipercolesterolemia familiar.

En personas con ECV establecida (enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular isquémica y enfermedad arterial periférica aterosclerótica) recomienda:

- estatinas de alta intensidad y
- aspirina 100 mg/día,

independientemente del valor de LDL colesterol.

Tabla de dosis de estatinas

	Baja intensidad (descensos de LDL colesterol <30%)	Moderada intensidad (descensos de LDL colesterol 30-50%)	Alta intensidad (descensos de LDL colesterol ≥50%)
Simvastatina	10 mg/día	20-40 mg/día	
Atorvastatina		10-20 mg/día	40-80 mg/día
Rosuvastatina		5-10 mg/día	20-40 mg/día

7. Detección de daño de órgano blanco

El daño de órgano blanco se refiere principalmente a:

- Hipertrofia ventricular izquierda (HVI).
- Fibrilación auricular (FA).
- Dilatación de aurícula izquierda (AI).
- Deterioro de la función renal y albuminuria.

El daño de órgano blanco detectado por cualquier método se asocia a incremento de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca y muerte.

Ante la presencia de daño de órgano blanco, la conducta es alcanzar el adecuado control de la presión arterial, por lo tanto, en la mayoría de los pacientes no se justifica retrasar el inicio del tratamiento antihipertensivo hasta tener el resultado de los estudios.

Para valorar la presencia de daño de órgano blanco se recomienda realizar dentro del año de diagnóstico:

- Electrocardiograma (ECG),
- Creatininemia y estimación del filtrado glomerular (FGe) y
- Relación albúmina/creatinina (RACo) en muestra de orina aislada.

De encontrarse disponible, la realización de un ecocardiograma podría mejorar la sensibilidad para detectar HVI, dilatación auricular y dilatación de raíz aórtica.

SI UNA PERSONA PRESENTA ECG NORMAL Y ALBUMINURIA NEGATIVA MUY PROBABLEMENTE NO PRESENTE DAÑO DE ÓRGANO BLANCO SECUNDARIO A HTA.

En adultos con HTA que al diagnóstico o durante el seguimiento, presenten alguna de las siguientes alteraciones:

- Albuminuria igual o mayor a 30 mg/g (en dos determinaciones),
- Deterioro del FGe por debajo de 60 ml/min/1,73m²

- ECG que sugiere daño de órgano blanco: hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, dilatación de aurícula izquierda,

se recomienda realizar un ecocardiograma para aumentar la precisión diagnóstica y cuantificar el daño.

LA PRESENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR (FA) REQUIERE DERIVACIÓN PRECOZ PARA VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO A FIN DE COMENZAR LA ANTICOAGULACIÓN ORAL Y DISMINUIR EL RIESGO DE ACV EMBÓLICO.

Cuando se detecte daño de órgano blanco, se recomienda:

- Ajustar el tratamiento antihipertensivo con metas más estrictas cercanas a 130/80 mmHg.
- Repetir ECG, FGe, RACo en muestra de orina aislada 1 vez al año.
- Realizar ecocardiograma cada 2 a 3 años.

En ausencia de daño de órgano blanco, se sugiere:

- Repetir ECG, FGe y RACo en muestra de orina aislada, cada 1 a 3 años.

Las personas con alto o muy alto riesgo de progresión a enfermedad renal terminal, pueden requerir mayor frecuencia de estudios y seguimiento conjunto con nefrología. Su abordaje específico excede los alcances de esta guía.

Ver anexo 4: pronóstico de enfermedad renal crónica según categorías de filtrado glomerular y albuminuria.

En adultos con HTA (sin diabetes mellitus ni alteraciones visuales), se sugiere:

- No realizar fondo de ojo para detección de retinopatía hipertensiva en forma rutinaria ya que no tiene un tratamiento específico más allá del control de la presión arterial y no aporta información adicional a la brindada por las pruebas para detectar daño de órgano blanco a nivel cardíaco y renal.

En el contexto de HTA maligna, preeclampsia o eclampsia (tópicos no abordados en esta guía) el Fondo de ojo constituye un pilar fundamental para el diagnóstico o el control de estos pacientes.

La HTA acelera la progresión de otras afecciones oculares como la retinopatía diabética y el estricto control de la PA enlentece su progresión.

Hemorragias subconjuntivales o “derrames”.

Las hemorragias subconjuntivales son procesos frecuentes de extravasación sanguínea entre las capas superficiales del ojo. Característicamente no producen síntomas ni alteraciones visuales. Si bien pueden obedecer a aumentos bruscos de la presión a nivel de la superficie ocular provocados por estornudos, tos o maniobras de valsalva que provocan rotura de capilares, las causas más frecuentes son traumatismos oculares menores, que generalmente pasan desapercibidos por los pacientes (incluido el “frotar” los ojos, uso de lentes de contacto). La evidencia actual no asocia hemorragia subconjuntival con eventos cardiovasculares a corto, mediano o largo plazo; por lo que su presencia no tendría utilidad para guiar el tratamiento antihipertensivo. En consecuencia, estos pacientes no se beneficiarían al ser evaluados de forma urgente. En casos de hemorragias subconjuntivales recidivantes se aconseja la consulta programada con un oftalmólogo.

Los siguientes test no son de utilidad en el abordaje de la HTA:

- **Ergometría** para diagnóstico, ni para guiar el tratamiento de HTA. No se ha podido establecer clara asociación entre la respuesta hipertensiva al ejercicio y la ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores.
- **Ecodoppler de vasos** de cuello para evaluar daño de órgano blanco. La medición del espesor íntimo medial carotídeo muy probablemente no mejore la predicción del riesgo cardiovascular respecto de la evaluación basada en los factores de riesgo cardiovasculares.

Orientación a solicitud de estudios complementarios

Prácticas	Dentro del año de Diagnóstico	Seguimiento	
		<i>Sin daño de órgano blanco</i>	<i>Con daño de órgano blanco</i>
Electrocardiograma	X	1 a 3 años	Anual
RACo	X	1 a 3 años	Anual*
Creatininemia y Fge	X	1 a 3 años	Anual*
Ecocardiograma	Ante signos de daño de órgano blanco en ECG y/o estudios de función renal	-----	2 a 3 años
Ionograma plasmático ante uso de AC-D o BB	X	1 a 3 años	
Ionograma plasmático ante uso de diuréticos TZ-STZ, IECA o ARAII	X	Anual	
Glucemia plasmática en ayunas**	X	ante glucemia normal: 3 a 5 años o más frecuente según criterio médico	
Colesterol total, HDL y TG	X	1 a 3 años	

* Las personas en estadios G4 y G5 pueden requerir determinaciones más frecuentes, el seguimiento se realiza en forma conjunta con nefrología y están fuera de los alcances de esta guía.

**REx procedente de la Guía de Práctica Clínica Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2^[11].

8. Adherencia al tratamiento

Tomar a diario la medicación suele ser un desafío para las personas con enfermedades crónicas. La adherencia al tratamiento farmacológico de la HTA al año de su inicio, típicamente reportada, es menor al 50%^[12].

Para las personas que necesitan tomar medicamentos varias veces al día es importante tener en cuenta el traslado, la reserva y reposición de la medicación.

La adherencia deficiente a la medicación se asocia al mal control de la presión arterial. Por lo tanto, evaluar la adherencia e implementar estrategias efectivas para superar las barreras, resulta un aspecto crucial en el tratamiento de la HTA.

En adultos con HTA se recomienda:

- La **atención por un equipo interdisciplinario**, centrada en la persona que aplique intervenciones integrales: comunicación, educación, seguimiento activo, algoritmos de tratamientos estandarizado, monitoreo de la presión arterial y apoyo al automanejo.
- Implementar la **entrevista motivacional** como estilo de atención.
- Implementar **intervenciones breves** diseñadas acorde a las necesidades particulares de la persona.
- Simplificar la prescripción con el uso de **fármacos de 1 sola toma al día** o combinación de dosis fijas (CDF) de 2 o más antihipertensivos en una píldora única.

Para ampliar atención en equipo, entrevista motivacional e intervención breve, ver anexo 2.

9. Manejo de la urgencia hipertensiva

La urgencia hipertensiva hace referencia a la situación clínica con valores de PA mayores a 180 mmHg de sistólica y/o 120 mmHg de diastólica, SIN SÍNTOMAS NI SIGNOS que evidencian lesión aguda en curso en órganos blanco, generalmente en personas con HTA conocida.

Es necesario diferenciar entre ^[13]:

- **emergencia hipertensiva:** presencia de síntomas específicos de daño agudo de órgano blanco,
- **urgencia hipertensiva:** sin síntomas específicos,
- **pseudocrisis o falsas urgencias:** elevaciones reactivas transitorias de la PA, debido a estimulación simpática como estrés, dolor, retención urinaria.

La distinción entre **urgencias y emergencias cambia la conducta**. El abordaje de las emergencias excede los alcances de esta GPC, solo se brinda a modo de orientación que:

- La anamnesis y el examen físico determinan el manejo ambulatorio o no.
- Los **síntomas de la emergencia hipertensiva** incluyen, entre otros:
 - dolor precordial (ej. isquemia miocárdica, infarto de miocardio, disección aórtica),
 - dolor de espalda (ej. disección aórtica),
 - disnea, edemas (ej. edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva),
 - síntomas visuales o neurológicos: cefalea, convulsiones, alteraciones visuales, alteración de la conciencia, o signos focales (ej. encefalopatía hipertensiva, ACV),
 - palpitaciones (ej.: arritmias)
 - polidipsia, poliuria, nocturia/nicturia, hematuria, oliguria, anuria (ej: insuficiencia renal aguda),
 - extremidades frías (ej.: claudicación intermitente).

LAS EMERGENCIAS REQUIEREN EVALUACIÓN INMEDIATA EN SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÁS ALLÁ DE LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL. SU ABORDAJE EXCEDE LOS ALCANCES DE ESTA GPC.

En adultos con **URGENCIAS HIPERTENSIVAS** se sugiere:

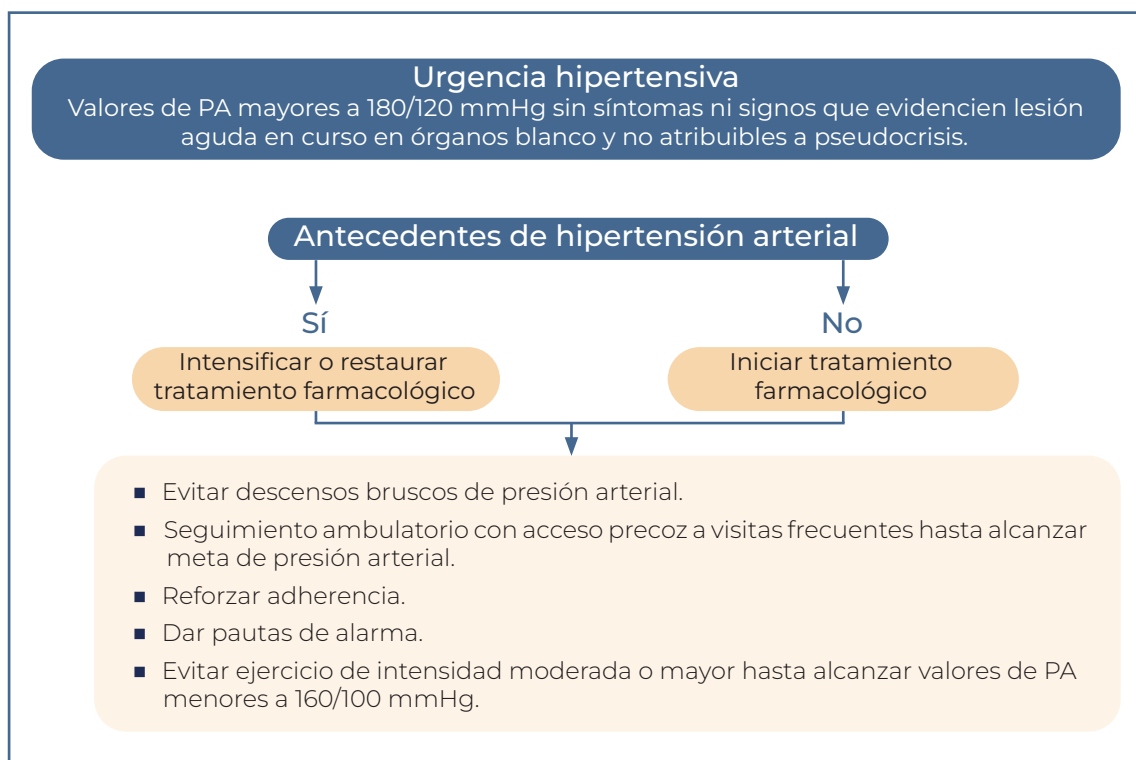
- **Manejo ambulatorio.**
- **Iniciar, reforzar o intensificar el tratamiento con antihipertensivos orales junto al reposo**, para una disminución gradual de la PA.
- Evitar la realización de ejercicio de intensidad moderada o mayor hasta alcanzar valores menores a 160/100 mmHg.

La mayoría de las urgencias hipertensivas ocurren en personas con HTA insuficientemente controlada y alrededor de un 25% de ellos desconocen su condición. En estos últimos, estos valores de presión arterial permiten establecer el diagnóstico de HTA en una sola consulta.

Se estima que el 75% de todas las crisis hipertensivas (valores de presión arterial >180/120 mmHg) evaluadas por guardia son urgencias, es decir, no presentan síntomas ni signos específicos de daño de órgano blanco en curso. Se espera una respuesta favorable con el reposo (30 minutos en ambiente tranquilo, puede ser sentado) en alrededor del 30% de las urgencias hipertensivas.

El descenso de presión arterial juega un papel fundamental, sin embargo, un descenso excesivamente rápido puede ser perjudicial (ej. la autorregulación cerebral posee márgenes más estrechos que otros órganos). Por eso, el mejor enfoque es una disminución gradual de la PA con un medicamento oral, evitando la reducción agresiva o inmediata.

Pseudocrisis o falsas urgencias: en ocasiones la elevación aguda de la PA es consecuencia de episodios agudos de ansiedad, pánico, epistaxis, presencia de dolor u otras emociones intensas o el consumo de ciertas drogas como: pseudoefedrina, anfetaminas, cocaína, etc. El reposo y tratamiento de estas condiciones (controlar epistaxis, aliviar cefalea, etc.), se asocia a descensos concomitantes de la PA. Los controles de seguimiento permitirán conocer los valores de PA fuera de estas situaciones. La frecuencia de cefaleas observada en personas con y sin HTA es similar.



10. Anexos

Anexo 1. Tabla de fármacos y dosis por grupos farmacológicos

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)			
Fármacos	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta
Enalapril	5 mg c/12 hs	10 mg c/12 hs	20 mg c/12 hs
Lisinopril	5 mg/día	10 mg/día	20 mg/día
Perindopril	2,5 mg/día	5 mg/día	10 mg/día
Ramipril	2,5 mg/día	5 mg/día	10 mg/día

Antagonistas del receptor de aldosterona II (ARAI)			
Fármacos	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta
Candesartán	8 mg/día	16 mg/día	32 mg/día
Irbesartán	75 mg/día	150 mg/día	300 mg/día
Losartán	25 mg/día	50 mg/día	100 mg/día
Olmesartán	10 mg/día	20 mg/día	40 mg/día
Telmisartán	20 mg/día	40 mg/día	80 mg/día
Valsartán	80 mg/día	160 mg/día	320 mg/día

Antagonistas cálcicos (AC-D)			
Fármacos	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta
Amlodipina	2,5 mg/día	5 mg/día	10 mg/día
Lercanidipina	5 mg/día	10 mg/día	20 mg/día
Nifedipina*	20-30 mg/día	40-60 mg/día	80-90 mg/día
*solo utilizar formulaciones de liberación prolongada.			

Betabloqueantes (BB)			
Fármacos	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta
Atenolol	25 mg/día	50 mg/día	100 mg/día
Bisoprolol	2,5 mg/día	5 mg/día	10 mg/día
Carvedilol	6,25 mg c/12 hs	12,5 mg c/12 hs	25 mg c/12 hs
Nebivolol	5 mg/día	10 mg/día	20 mg/día
Metoprolol*	50 mg/día	100 mg/día	200 mg/día
* Utilizar formulaciones de liberación prolongada.			

Tiazidas (TZ-STZ)			
Fármacos	Dosis baja	Dosis media	Dosis alta
Clortalidona	6,25 mg/día	12,5 mg/día	25 mg/día
Hidroclorotiazida	12,5 mg/día	25 mg/día	50 mg/día**
Indapamida	1,25 mg/día	2,5 mg/día	---

**dosis no recomendada, por elevada tasa de efectos adversos

Anexo 2. Adherencia al tratamiento

Atención basada en equipos interdisciplinarios

La atención basada en equipo es un modelo organizacional que propone la redistribución estratégica del trabajo entre los miembros del equipo de salud definiendo claramente los roles, con el fin de mejorar la calidad de atención y los resultados clínicos.

Promueve el trabajo colaborativo y apunta a mejorar:

- el seguimiento de los pacientes y apoyo al automanejo,
- la adherencia al tratamiento y gestión de medicamentos
- el acceso a la atención y los tiempos de espera,
- el control de la HTA y comorbilidades asociadas, como la diabetes mellitus y
- el nivel de satisfacción de los pacientes y del equipo de salud.

Su implementación incluye:

- capacitación y entrenamiento para la adquisición de nuevas competencias acorde a la redistribución de roles (quién tiene a cargo la toma y registro de la presión arterial, etc.),
- evaluación del desempeño,
- desarrollo de flujogramas de proceso y
- uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar el seguimiento activo de los pacientes y la comunicación entre los miembros del equipo.

Para ampliar en el tema puede consultarse el Plan Nacional de Prevención y Control de la Hipertensión Arterial en el siguiente link: <https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo>

Intervención breve

- ▶ tiene una duración total de 10 a 20 minutos, que se pueden aplicar en una o varias consultas
- ▶ comprende a diferentes integrantes del equipo de salud

La HTA, es un problema complejo y fluctuante, por lo que los diferentes pasos de la intervención requieren ser aplicados reiteradas veces a lo largo del seguimiento.

La intervención breve, también conocida como intervención de las “las 5 A” consta de 5 pasos, que en la versión adaptada a la **adherencia al tratamiento** son:

1. Averiguar y evaluar.
2. Aconsejar, transmitiendo mensajes claros y convincentes.
3. Acordar, estableciendo metas de cambio.
4. Ayudar a realizar el cambio aumentando la motivación y el nivel de confianza.
5. Acompañar con el seguimiento.

1. *Averiguar y evaluar.*

Es fundamental en la evaluación de la adherencia para poder diseñar intervenciones a medida. La falta de adherencia suele provocar frustración y enojo, afectando la motivación tanto del equipo de salud como de la persona e impactando negativamente en el vínculo que existe entre ambos.

Entender y respetar el marco de referencia de la persona y no intentar imponer el propio es clave a la hora de motivar a la persona para que tome sus propias decisiones y así favorecer su empoderamiento.

¿Qué es necesario evaluar?

- Características del problema.
- Acceso a medicamentos y otros insumos.
- El contexto familiar y social.
- La disposición al cambio.
- Conocimientos previos y soluciones intentadas.

¿Cómo evaluar la adherencia?

- Utilizar **preguntas abiertas**, que promueven la reflexión acerca del problema y contribuyen a identificar barreras y facilitadores.
- **expresar empatía y aceptación** a pesar de las fluctuaciones, dando a entender que lo esperable es que la conducta pueda no ser la ideal.

Ej. ¿Qué significa para usted tener hipertensión?, ¿Qué piensa usted de la medicación que tiene que tomar para presión? La mayoría de las personas tienen dificultades en tomar todos los medicamentos, ¿por qué no me cuenta cómo le va a usted?

Existen también algunos cuestionarios para evaluar la adherencia, como el Morisky Green y el Haynes-Sackett que se describen más adelante.

2. *Aconsejar.*

Al aconsejar es importante **transmitir mensajes claros y convincentes**. Comunicar la importancia de incorporar la pauta centrándose en los beneficios de su incorporación.

Ej. aconsejar con frases como: “los antihipertensivos son fármacos que han demostrado salvar muchas vidas, por eso, como su médico, le recomiendo que lo tome con confianza”.

3. Acordar.

El tratamiento de las enfermedades crónicas requiere, la mayor parte de las veces, modificar radicalmente el estilo de vida de la persona.

La persona probablemente atraviese diferentes etapas por lo que es poco factible que todos estos cambios los realice simultáneamente, de un día al otro. **Por eso es importante acordar con la persona por dónde empezar.** Algunos prefieren empezar por aquello que les resulta más fácil (ej. tomar medicamentos) y otros asumir el desafío de comenzar por lo más difícil (ej. dejar de fumar). En cualquier caso, el rol del equipo de salud es promover el empoderamiento de la persona e invitarlo a **participar activamente en el establecimiento de metas.**

4. Ayudar.

Para ayudar a las personas a realizar cambios es necesario:

- Aumentar su motivación.
- Trabajar con los beneficios.
- Aumentar su nivel de confianza.

Aumentar su motivación.

La entrevista motivacional es un estilo de comunicación directivo, centrado en la persona, que se basa en la identificación y la movilización de los valores y metas de la persona para estimular el cambio. Intenta que la motivación a cambiar surja de la persona y no sea impuesta por el equipo de salud, y está diseñada para ayudar a resolver la ambivalencia, es decir, la situación en la que una persona tiene sentimientos contradictorios sobre algo. Esta ambivalencia es normal frente a la decisión de emprender un cambio de comportamiento que puede resultar beneficioso, pero demanda sostener un considerable esfuerzo. Así la persona oscila entre las razones para cambiar y las razones para continuar igual.

Los principios de la entrevista motivacional son:

- **Expresar empatía:** la escucha activa y la aceptación facilitan que la persona se disponga a reflexionar acerca del problema.
- **Ayudar a la persona a identificar que algo no va en la dirección que quiere:** explicitar contradicciones, es decir, mostrarle a la persona las diferencias entre “lo que dice y piensa” en relación al cuidado de su salud, y “lo que hace” para lograrlo, es otra estrategia efectiva para favorecer el cambio, es invitarlo a reflexionar sobre su conducta. Siempre con actitud empática, usando afirmaciones y preguntas abiertas.

Ej. si una persona “dice” que quiere hacerse estudios porque considera que es muy importante cuidarse, se le puede invitar a reflexionar si lo que hace, “fumar”, se relaciona con lo que dice, “es importante cuidarse”.

- **Evitar la discusión:** tratar de convencer a alguien para que cambie suele conducir a que la persona se oponga. Si la persona siente que su capacidad de elección está limitada, crea resistencias que dificultan el cambio. Hay que tener en cuenta qué es lo que la persona está

dispuesta a hacer o no, qué quiere saber o no, y que exprese ella misma sus propios motivos para cambiar.

- **Dar un giro a la resistencia:** desde este enfoque, quien conduce la entrevista no impone nuevos puntos de vista u objetivos, sino que invita a la persona a considerarlo, generando preguntas y problemas a la persona para que sea ella quien encuentre sus propias soluciones.

Trabajar con los beneficios

Si bien es importante que la persona conozca los riesgos de su conducta (fumar, comer con sal, abandonar la medicación) y es necesario informarla para que pueda decidir que es recomendable que haga y que no para cuidarse, **no es una buena estrategia centrarse en los riesgos** ya que suele provocar confrontaciones y aumentar la resistencia al cambio. Por el contrario, centrarse en los beneficios que le traerá el cambio de comportamiento, es una estrategia que ha mostrado ser más efectiva para alcanzar cambios duraderos.

Ej. en lugar de decirle: “Si no toma los medicamentos, va a tener un ACV”, se le puede decir: “Tomar los medicamentos como le recomendó el médico ayuda a prevenir la aparición de las complicaciones que la HTA puede ocasionar en las arterias del cerebro o el corazón”.

Aumentar su nivel de confianza

Para que una persona alcance una meta, además de contar con los conocimientos y habilidades, necesita confiar en sí misma en que podrá lograrlo. El rol del equipo aquí es facilitar que la persona confíe en su capacidad para enfrentar obstáculos, brindando opciones y ayudándola a comprometerse en el proceso de toma de decisiones.

Es necesario tener en cuenta:

- La adherencia no es mala o buena, no es todo o nada. Tiene grados y puede variar en diferentes aspectos del tratamiento.
- No centrarse en señalar las faltas de cumplimiento.
- Identificar y señalar positivamente los logros, aquellas pautas saludables que la persona pudo incorporar, ayudará a que la persona confíe en sí misma y pueda alcanzar nuevas metas.

5. Acompañar con el seguimiento.

Aprovechar cada encuentro para mantener la motivación, evaluar el progreso, proveer retroalimentación y, de ser necesario, ajustar el plan alcanzando nuevos acuerdos.

Reevaluar utilizando preguntas abiertas:

- Chequear logros, avances y retrocesos.
- Evaluar nivel de motivación, confianza, capacidad para tomar decisiones.
- Señalar positivamente los logros.
- Revisar el plan y, si es necesario, acordar nuevas metas.

*¿Cómo estuvo este mes/semana? ¿Qué ha podido lograr?
¿Cómo cree que puedo ayudarle a mejorar?*

Test de cumplimiento autocomunicado o test de Haynes-Sackett

Primero se pregunta: La mayoría de pacientes tienen dificultades en tomar todos sus comprimidos, *¿tiene usted dificultades en tomar los suyos?*

Si la respuesta es afirmativa se considera mala adherencia.

Si responde que no, es posible que no diga la verdad y en ese caso se repregunta: *¿cómo los toma?* todos los días, muchos días, algunos días, pocos días o rara vez.

Finalmente, se realiza una tercera pregunta y se recoge lo que el paciente mencione sobre la siguiente reflexión: «Muchas personas tienen dificultad en seguir los tratamientos, ¿por qué no me comenta cómo le va a usted?»

Test Morisky-Green

1. *¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?*
2. *¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?*
3. Cuando se encuentra bien, *¿deja de tomar la medicación?*
4. Si alguna vez le sienta mal, *¿deja usted de tomarla?*

El paciente es considerado como adherente si responde: No/Sí/No/No.

Otra variante modifica la segunda pregunta por *¿olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas?*, para que las 4 respuestas sean “NO”.

Para ampliar en el manejo de la adherencia puede acceder al curso “Educación para el automanejo de enfermedades crónicas. Herramientas para el equipo de salud” en la Plataforma Virtual de Salud que se realiza todos los años.

Anexo 3. Pruebas para evaluar fragilidad

Para valorar fragilidad a los fines de aplicar las recomendaciones de esta GPC podría utilizarse la herramienta FRAIL o la prueba breve de desempeño físico.

Herramienta FRAIL

Es una herramienta de fácil aplicación. Está compuesta por 5 ítems (fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso)^[4]. Cada respuesta afirmativa es valorada con 1 punto.

- **Fatigabilidad:** ¿Se siente usted fatigado?
- **Resistencia:** ¿Puede subir más de un piso de escaleras?
- **Deambulación:** ¿Puede caminar más de una cuadra?

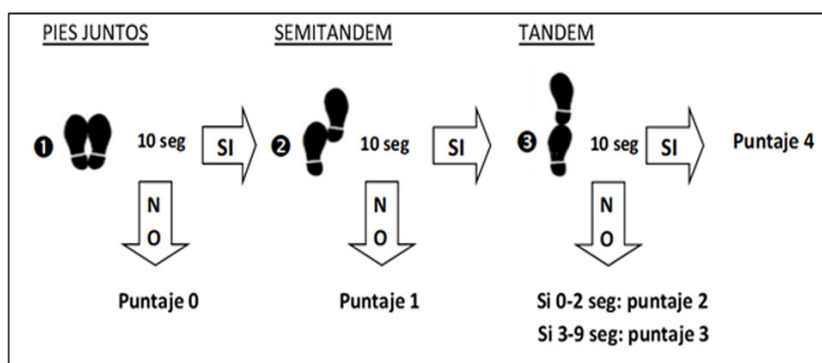
- **Comorbilidad:** ¿Tiene más de 5 padecimientos o enfermedades? (HTA, diabetes mellitus, cáncer, EPOC, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, asma, artropatías, ACV, ERC).
- **Pérdida de peso:** ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses?

Interpretación: puntuación igual o mayor a 3 se considera fragilidad/vulnerabilidad. Puntuación 1 a 2 se considera prefragilidad.

Prueba breve de desempeño físico

La prueba breve de desempeño físico (Short Physical Performance Battery -SPPB-)[15] incluye 3 test que la persona tiene que realizar en el siguiente orden:

- Test de equilibrio o prueba cronometrada en posición de pie.
- Test de velocidad de la marcha.
- Levantarse de una silla.



A. El test de equilibrio consiste en que la persona intente mantener 3 posiciones: pies juntos, semitándem y tándem durante 10 segundos cada una, siguiendo dicha secuencia:

B. Velocidad de la marcha: se cronometra el tiempo que tarda la persona en realizar un recorrido a pie de una distancia de 4 metros en su ritmo habitual. Este test se realiza 2 veces y se registra el tiempo más breve.

C. Levantarse de una silla 5 veces: usando una silla, se le pide a la persona que se levante y siente 5 veces, con los brazos cruzados, en el menor tiempo posible y se registra el tiempo total empleado.

Puntuación

Cada test se puntúa de 0 (peor rendimiento) a 4 (mejor rendimiento). Puntaje total de la batería: 12 puntos.

Test de equilibrio según una combinación jerárquica del desempeño en los 3 pasos

Tiempo en segundos	Puntos
Equilibrio con pies juntos incapaz o entre 0-9	0
Equilibrio con pies juntos 10 + semitándem < 10	1
Pies juntos 10 + semitándem 10 + tándem entre 0 y 2	2
Pies juntos 10 + semitándem 10 + tándem entre 3 y 9	3
Pies juntos 10 + semitándem 10 + Tándem 10	4

Test de velocidad de la marcha

Tiempo en segundos	Puntos
No lo puede realizar	0
mayor a 8,7	1
6,2 a 8,7	2
4,82 a 6,2	3
menor a 4,82	4

Test levantarse de una silla 5 veces:

Tiempo en segundos	Puntos
No lo puede realizar	0
Mayor o igual a 16,7	1
13,7 a 16,69	2
11,2 a 13,69	3
Menor o igual 11,19	4

Interpretación: por debajo de 10 se considera fragilidad/vulnerabilidad.

Anexo 4.
Pronóstico de la enfermedad renal crónica según categorías de filtrado glomerular y albuminuria^[16]

Filtrado glomerular Categorías, descripción y rangos: GRADOS G		Albuminuria (RACo) Categorías, descripción y rangos:		
		A1	A2	A3
		Normal a ligeramente elevada	Moderadamente elevada	Gravemente elevada
		<30 mg/g	30-300 mg/g	>300 mg/g
G1	Normal o elevado			
G2	Ligeramente disminuido			
G3a	Ligera a moderadamente disminuido			
G3b	Moderada a gravemente disminuido			
G4	Gravemente disminuido			
G5	Falla renal			

	Bajo riesgo
	Moderado riesgo
	Alto riesgo
	Muy alto riesgo

RACo: relación/ albúmina
creatinina en orina.

Adaptado de KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

Anexo 5. Herramientas para identificar factores psicosociales

Escala de rastreo de trastorno de ansiedad generalizada GAD-7

La escala GAD-7 es un instrumento sencillo, de fácil aplicación, útil para detectar casos probables de trastorno de ansiedad generalizada en la consulta ambulatoria ^[17].

GAD-7 : cuestionario para rastreo de trastorno de ansiedad generalizada				
Durante las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia sintió molestias por los siguientes problemas?	Ningún día	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Sentirse nervioso, ansioso o con los nervios de punta	0	1	2	3
2. No poder dejar de preocuparse o no poder controlar la preocupación	0	1	2	3
3. Preocuparse demasiado por diferentes cosas	0	1	2	3
4. Dificultad para relajarse	0	1	2	3
5. Estar tan inquieto que es difícil permanecer sentado quieto	0	1	2	3
6. Enojarse o irritarse con facilidad	0	1	2	3
7. Sentirse con miedo como si algo terrible fuera a suceder	0	1	2	3

El punto de corte de 10 puntos tiene una sensibilidad de 86,8% una especificidad de 93,4% como prueba de rastreo de trastorno de ansiedad generalizada.

Cuestionario para rastreo de depresión PHQ-9

El PHQ-9 es una herramienta breve para evaluar la presencia y severidad de síntomas de depresión, validado en Argentina^[18,19].

PHQ-9: cuestionario para rastreo de depresión				
Durante las últimas dos semanas ¿con qué frecuencia tuvo molestias por cualquiera de los siguientes problemas?	Ningún día	Varios días	Más de la mitad de los días	Casi todos los días
1. Poco interés o placer en hacer cosas.	0	1	2	3
2. Sentirse decaído, deprimido, o desesperanzado	0	1	2	3
3. Dificultad para dormir o permanecer dormido o dormir demasiado.	0	1	2	3
4. Sentirse cansado, o con poca energía.	0	1	2	3
5. Con poco apetito o comer demasiado.	0	1	2	3
6. Sentirse mal consigo mismo o sentir que uno es un fracaso o que le ha fallado a su familia o a sí mismo.	0	1	2	3
7. Dificultad para concentrarse en cosas, tales como leer el diario o ver la televisión.	0	1	2	3
8. ¿Se ha movido o hablado más lentamente que otras personas lo notaron? O, por el contrario — ha estado más inquieto, intranquilo, moviéndose más de lo habitual.	0	1	2	3
9. Pensamientos de que usted estaría mejor muerto, o de hacerse daño a sí mismo de alguna manera.	0	1	2	3

Se consideran puntos de corte óptimos:

- 6–8 para síntomas de depresión leve
- 9–14 para síntomas de depresión moderada
- 15 o más para síntomas de depresión severa

Referencias

1. **Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** Guía de Práctica Clínica Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial” 2019.
2. **Yusuf S, Joseph P, Rangarajan S, Islam S, Mente A, Hystad P, et al.** Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. *Lancet*. 2019. doi:10.1016/S0140-6736(19)32008-2
3. **Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación Argentina;
4. **Stergiou GS, Bliziotis IA.** Home blood pressure monitoring in the diagnosis and treatment of hypertension: a systematic review. *Am J Hypertens*. 2011;24: 123–134.
5. **Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al.** 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2025;86: 1567–1678.
6. **Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** Manual para la aplicación de las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Ministerio de Salud de la Nación Argentina;
7. **Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Intervención Breve para Reducir el Consumo de Alcohol. Ministerio de salud de la Nación Argentina; 2024.
8. **Ministerio de Salud de la Nación.** Guía de Práctica Clínica Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco. Ministerio de Salud de la Nación;
9. **Ministerio de Salud de la Nación A.** Guía de Práctica Clínica Nacional de Abordaje Integral de la Obesidad en adultos, 2023. Versión breve. In: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2023-12/gpc-obesidad-breve.pdf>.
10. **Ministerio de Salud de la Nación.** Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención Cardiovascular. 2021. Ministerio de Salud de la Nación Argentina; 2021.
11. **Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2. 2019.
12. **Burnier M, Egan BM.** Adherence in Hypertension. *Circ Res*. 2019;124: 1124–1140.
13. **Albaladejo Blanco C, Sobrino Martínez J, Vázquez González S.** Crisis hipertensivas: pseudocrisis, urgencias y emergencias. *Hipertensión y Riesgo Vascular*. 2014;31: 132–142.
14. **Morley JE, Vellas B, van Kan GA, Anker SD, Bauer JM, Bernabei R, et al.** Frailty Consensus: A Call to Action. *Journal of the American Medical Directors Association*. 2013. pp. 392–397. doi:10.1016/j.jamda.2013.03.022
15. **Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, et al.** A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. *J Gerontol*. 1994;49: M85–94.
16. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024;105: S117–S314.
17. **García-Campayo J, Zamorano E, Ruiz MA, Pardo A, Pérez-Páramo M, López-Gómez V, et al.** Cultural adaptation into Spanish of the generalized anxiety disorder-7 (GAD-7) scale as a screening tool. *Health Qual Life Outcomes*. 2010;8: 8.

18. **Urtasun M, Daray FM, Teti GL, Coppolillo F, Herlax G, Saba G, et al.** Validation and calibration of the patient health questionnaire (PHQ-9) in Argentina. BMC Psychiatry. 2019;19: 291.
19. **Patient Health Questionnaire (PHQ).** Available: <https://www.phqscreeners.com/>

0800.222.1002
argentina.gob.ar/salud
Av. 9 de Julio - 1925. C.A.B.A



**Ministerio
de Salud**
República Argentina